



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رجاء عبدالستار علي حميده
المحافظة : بني سويف الحي / المدينة : الواسطي
رقم البطاقة : 28008202201748 رقم التليفون : 01001833754
العنوان : اطيح
العمر (تاريخ الميلاد) : 20-08-1980 المهنة : حاصل علي بكالوريوس
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : -----
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : -----
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رجاء عبدالستار علي حميده National ID: 28008202201748	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Dms
مقطوع على الصلابة
تدعى





AMS
مقطع



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Populationالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:

1- Name : رجاء عبدالستار علي حميدة

Sex:

3- Medical number:

Female

83186247

Old Med :

Old Med :

410-2024

Z-ID number:

Patient Age : 44 Y



Family history

Family history
-ve

Phone

Phone
01114620478

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
HIST NAME

marital status

marital status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

21/08/2024

Co-morbidity

Co-morbidity

Menopausal
statusMenopausal Status
PREMENOPAUSAL

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

LT BIRADS 4c 2 oclock

Mets Workup :

free

BX

IDC

BX COMMENT

ER

0/8

ER COMMENT

PR

0/8

PR COMMENT

Her 2 Neu

0

Her 2 Neu COMMENT

SISH

SISH COMMENT

Ki67

40

T

2

N

1

M

0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

received 4AC + 4 taxotere / carboplatin with good regression

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

for It bracketing then It WLE & SLNB

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

SURGERY

Psychiatric

Psychiatric

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition



Patient Name	: الأستاذ / رجاء عبد الستار علي حميدة	Request No.	: 13004490
Patient No.	: 28008202201748	Request Date	: 29/04/2024
Path No.	: 1398/24	Verification Date	: 08/05/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data

Thick endometrium, breast cancer post RACT

Nature of specimen

D&C

Gross specimen

Multiple hemorrhagic tissue pieces measured collectively 1x1 cm, totally submitted

Microscopic examination

Microscopic examination revealed multiple fragments of endometrial tissue formed of rounded tubules and irregular widely spaced glands lined by columnar and cuboidal cells with focal secretory changes surrounded by hyperplastic spindle stroma associated with fragments having fibrous stroma entangling thick walled vessels denoting polyp formation, some inflamed cervical tissue fragments were regarded, No evident atypia

Diagnosis

Endometrial thickening, D&C

-Irregular shedding

-Hyperplastic endometrial polyp without atypia

-Chronic cervicitis

Signature

Dr. Rana Fathy

Dr. Heba Hassan

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 08/05/2024 13:29:21

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / رجاء عبد الستار علي حميدة	Request No. : 13005275
Patient No. : 28008202201748	Request Date : 07/02/2024
Path No. : SR-176/24	Verification Date : 14/02/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.
Nature of Specimen: Slide Revision

Gross Examination:

- one paraffin block labeled by (820532) and (5) slides were received.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade (3+2+1) II.
- * DCIS: Can't be detected.
- * Angioinvasion: Can't be detected.
- * Perineural invasion: Can't be detected.
- * IPT:
- ER: No nuclear reaction in the tumor cells (score 0/8).
- PR: No nuclear reaction in the tumor cells (score 0/8).
- Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).
- Ki67: 40% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast cancer, Slide revision:

Invasive duct carcinoma Grade II

IPT:

- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 40% of tumor cells

Signature

Verified by :

Dr. Sagda El-Kady

Patient: Rana A. Elgattar Ali
Exam: BILATERAL SONO- MAMMOGRAPHY

ID:
DATE: 20/01/2024

MAMMOGRAPHY REPORT

Dear colleague, thanks for refer

Bilateral Soft Tissue Mammography with Complementary Ultrasound Revealed

Clinical background: Mastalgia.

Findings:

- Both breasts show scattered fibroglandular parenchyma (A/B).
- Left breast UOQ focal asymmetry with grouped pleomorphic calcifications.
- No right spiculated masses or pathological micro-calcifications.
- U/S showed left breast UOQ 2 o'clock irregular speculated, hypoechoic avascular mass lesion measures 17 x 27 mm.
- few subcentimetric simple cysts.
- No right solid lesions.
- No evidence of duct ectasia.
- Normal skin thickness and contour
- Right nonspecific axillary lymph nodes of preserved fatty hilae.
- Pathological left axillary level I lymph nodes the largest one measures 8 x 14 mm.

CONCLUSION:

- Left breast UOQ malignant looking mass lesion and calcifications BIRADS 4c, For biopsy.
- Bilateral fibroadenosis with cystic changes.

Best Regards,
Dr. Wafaa Heidar, MSc



Patient Name: Ragaa Abd El Sattar Ali Hmida	Date : 03/03/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 410/2024	Pat. ID: 47424

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

left breast IDC

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows UOQ spiculated irregular mass lesion, of high density with grouped pleomorphic microcalcification involving an area about 33 x 20 mm.
- Complementary ultrasound revealed left breast irregular spiculated hypoechoic mass lesion, with subtle vascularity detected within on color Doppler, seen at 2 o'clock position, measuring 1.8 x 2.7 cm, consistent to the palpable lump.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Pathological left axillary lymph nodes are seen with muffled hila, the largest measuring 1x1.4cm
- Nonspecific right axillary LN.

Opinion:

- Left breast UOQ malignant mass lesion and microcalcifications proved IDC (BIRADS 6).
- Pathological left axillary LNs.

Yours truly

Dr.Wafaa Ali

Name: RAGAA A AL SATAR ALI

Pat. ID: CHEST ABD CONTRAST 233424

Date : 8/2/2024

**POST-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST
ABDOMEN AND PLEVIS WITH CORONAL RECONSTRUCTION
REVEALED:**

A known case of pathological proven infiltrative duct carcinoma grade iii.

I-CHEST

- > Clear both lung fields with no evidence of sizable pulmonary masses, nodules or cavitations.
- > No pathological enlarged lymph nodes.
- > No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- > Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- > Normal enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels,
- > Left breast soft tissue lesion is noted.
- > Multiple bilateral axillary lymph nodes are noted with the largest measures about 15 mm .

II-ABDOMEN AND PELVIS

- > The liver is marked enlarged in size showing homogenous low parenchymal texture with regular outlines. No sizable focal lesions.
- > No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- > Radio-dense surgical clips are noted at the gall bladder bed.
- > Mild enlarged spleen showing homogenous texture with multiple small calcifications are noted .
- > Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no sizable stones or back-pressure changes.
- > Normal appearance of the pancreas, aorta and I.V.C.
- > Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular out pouching.
- > No ascites.
- > No CT evidence of pathological enlarged lymph nodes.
- > No abdominal or pelvic masses seen.
- > Bulky uterus with widened endometrial cavity with hypodense appearance.

OPINION

A known case of pathological proven infiltrative duct carcinoma grade III.

- Left breast soft tissue lesion.
- Multiple bilateral axillary lymph nodes are noted with the largest measures about 15 mm.
- Normal CT study of the chest.
- Fatty hepatomegaly
- Mild splenomegaly with multiple calcifications foci.

*MUCH OBLIGED,
DR: MOHAMED SOLIMAN, MD
CONSULTANT RADIOLOGY*



Patient Name:	Ragaa AbdelSattar Ali Hameeda	Patient Gender:	Female
Patient Code:	Q40511	DATE:	3/10/2024 12:15:04 PM

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

Clinical history

- Female patient with history of left breast cancer.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake is seen that would account for bone deposits.
- Arthritic changes of knees are noted

Opinion

- No convincing scintigraphic evidence of metastatic osseous lesions.

Dr. Hesham Magdy

Dr. Nahla Dessoki, MD